

全院智能体管理情况报告

本报告基于统一台账中心 2026 年第二季度(2026-04-01 至 2026-06-30)聚合数据,覆盖接入中心、准入评测沙盒、统一运行监控中心及院内数据系统,用于向院领导及上级主管部门汇报全院智能体建设与运行情况。

一、建设概况

截至 2026-06-30,全院已纳管智能体 86 个,较上季度新增 18 个,环比提升 26.5%;科室覆盖率达 78.6%,较上季度提升 5.4 个百分点。本季度总调用量达 286.4 万次,正常运行率 98.6%。



图 1 · 近 6 月新增纳管智能体数量趋势

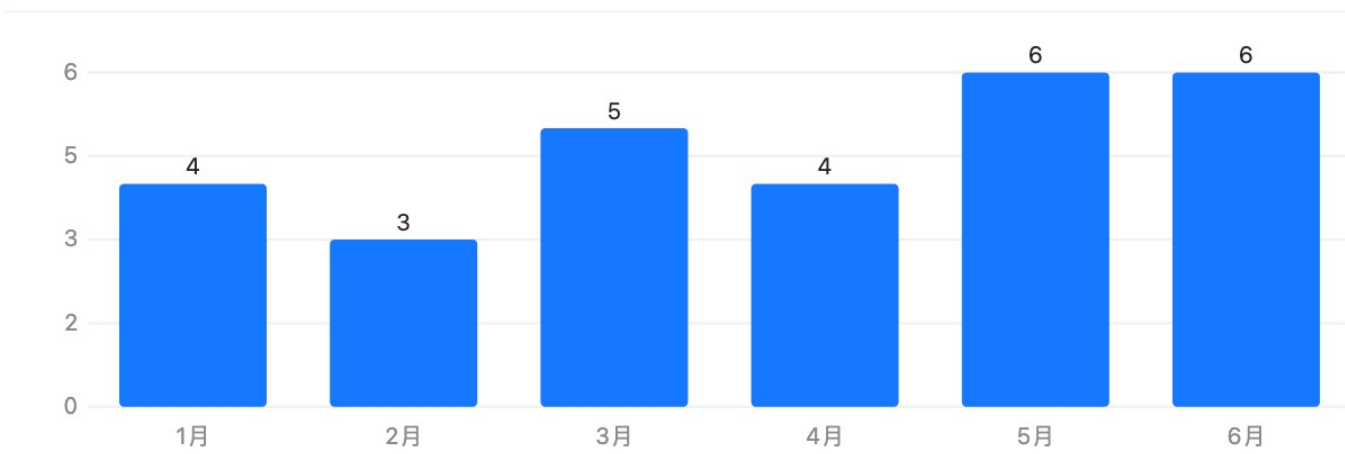


图 2 · 智能体科室分布(TOP10)

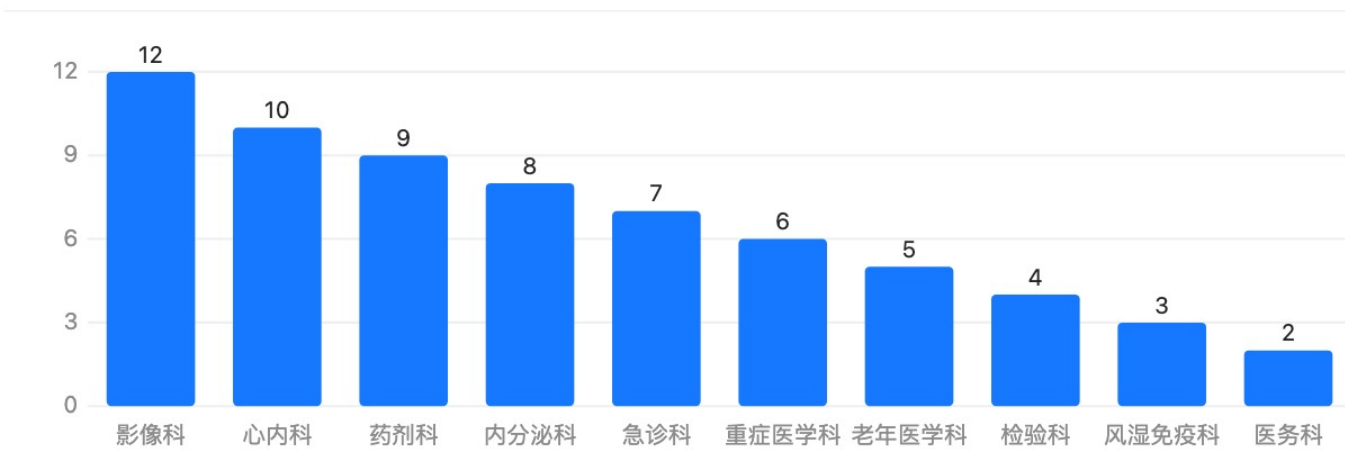
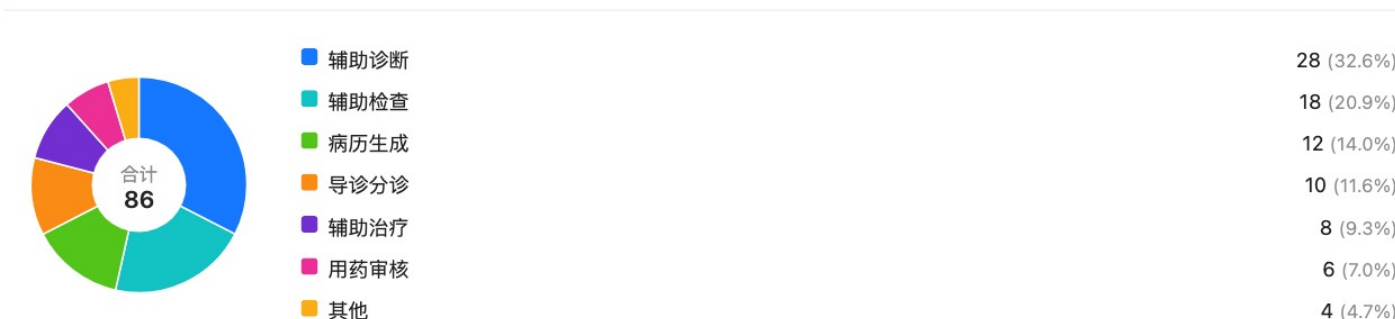


图 3 · 智能体诊疗环节分布



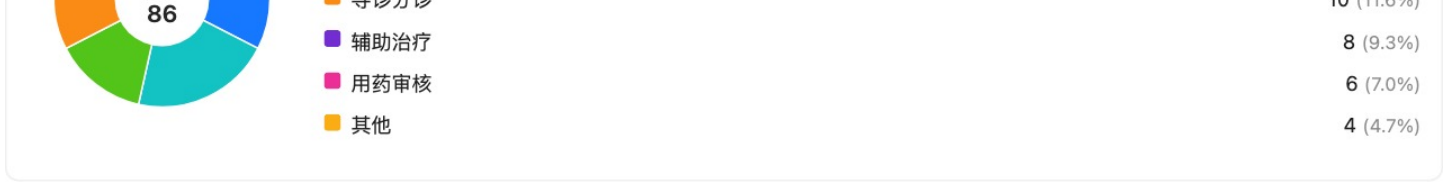


图 4 · 智能体来源分布

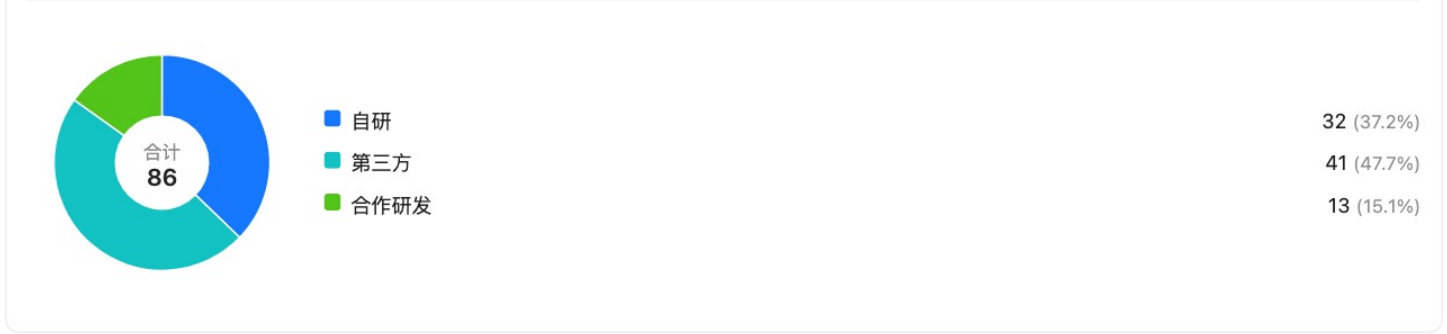
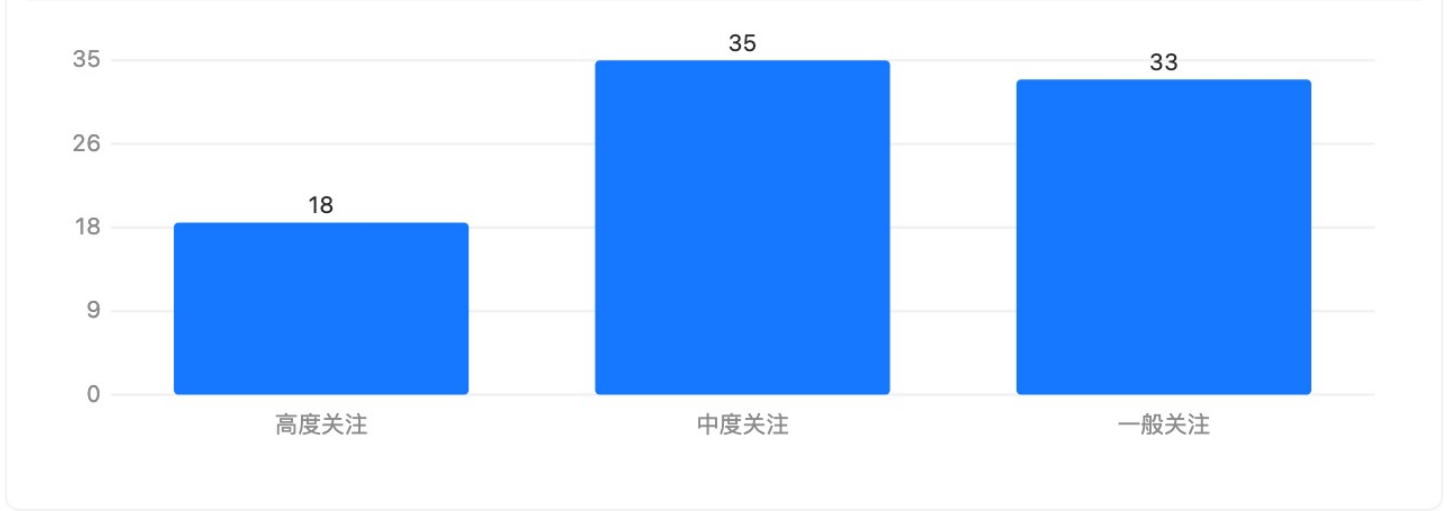


图 5 · 智能体风险分级情况



二、关联资源对接情况

全院智能体累计与院内 HIS、PACS、LIS、EMR 等数据系统建立对接 246 次,正常对接 238 次,异常对接 8 次(其中 EMR 字段映射异常 4 次、PACS 接口超时 3 次、LIS 鉴权过期 1 次),异常对接均已通知资源负责人并跟踪处理。

表 1 · 异常对接清单

对接资源	智能体	对接方式	异常描述	处理进展
EMR 电子病历	肺结节智能筛查系统	HL7/FHIR	字段映射错误,报告生成失败	已修复 · 等待复测
PACS 影像归档	冠脉 CTA 评估助手	API	接口响应超时 > 2s	已通知厂商 · 进行中
LIS 检验系统	智能预问诊 v2.1	数据库直连	鉴权证书过期	已续期 · 验证中

三、准入评测情况

本季度共 18 个智能体进入评测流程,其中待评测 8 个、评测中 4 个、评测完成 6 个。评测完成中准入通过 5 个(通过率 83.3%)、退回修改 1 个(退回原因主要集中在安全性与可解释性维度)。

王主任 批注:"通过率 83.3%"请补充同比去年数据

图 6 · 准入评测进度漏斗(待评测 / 评测中 / 评测完成)



图 6 · 准入评测进度漏斗(待评测 / 评测中 / 评测完成)

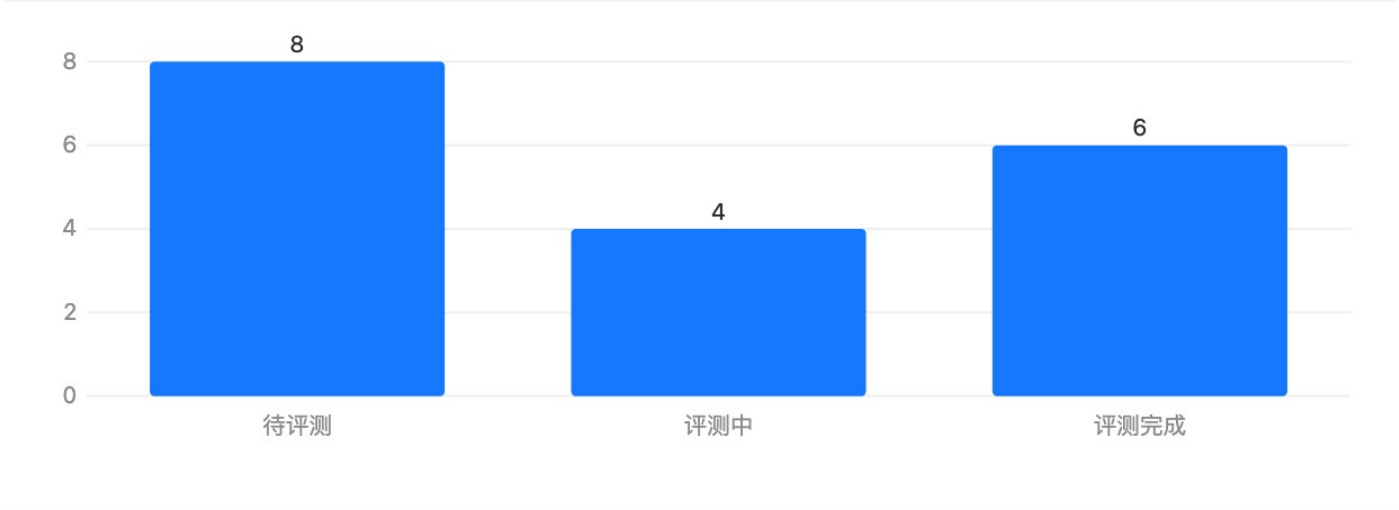


图 6b · 评测完成中准入通过 vs 退回修改占比(6 个评测完成智能体)

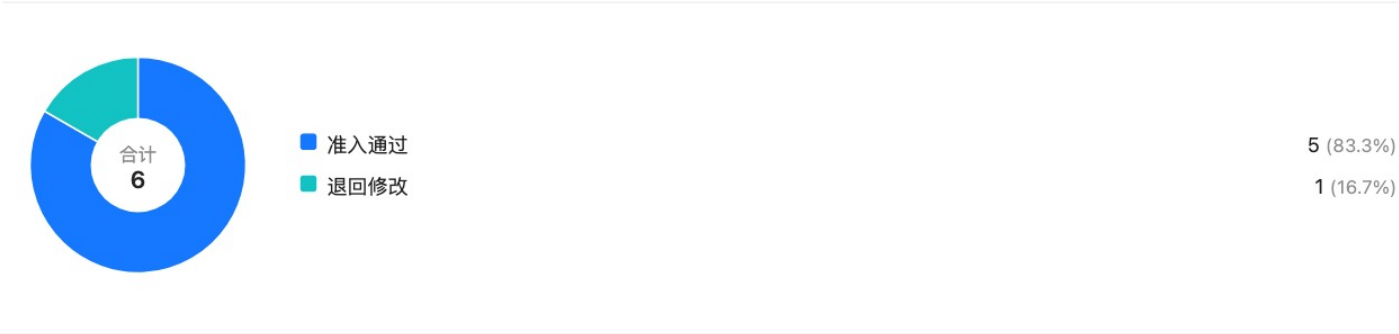
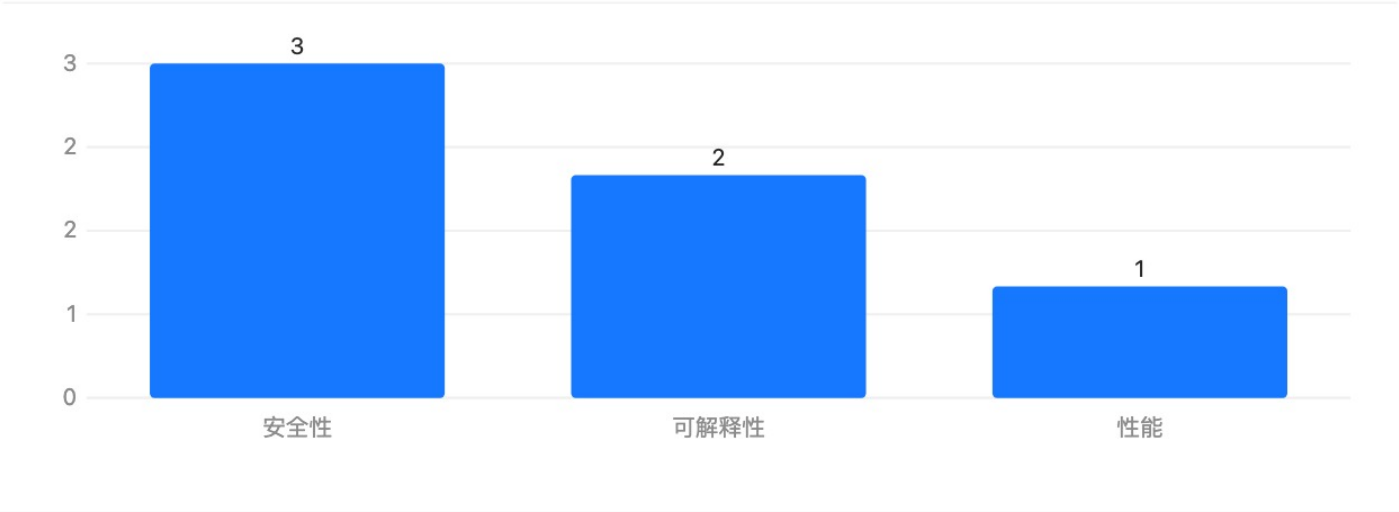


表 2 · 退回修改原因分析(按维度归类)

退回维度	次数	占比	典型原因
安全性	3	50%	数据脱敏不充分
可解释性	2	33%	决策依据不可追溯
性能	1	17%	响应时间超标

图 6c · 退回修改原因归类柱状图



四、运行健康

本季度告警

142 次

本季度故障

23 次

已恢复

139 次

平均恢复时长

38 分钟

本季度告警

142 次

本季度故障

23 次

已恢复

139 次

平均恢复时长

38 分钟

图 7 · 告警/故障月度趋势



表 3 · 典型问题及处理方案

问题分类	频次	代表案例	处理方案
EMR 字段映射错误	4	肺结节 AI 报告生成失败	统一映射规范 + 自动化校验
PACS 接口超时	3	CTA 评估响应慢	升级代理带宽 + 缓存层
GPU 资源争抢	5	影像科多智能体并发瓶颈	弹性调度 + 优先级队列

五、存在的问题与下一步工作建议

当前存在的主要问题包括:① 科室覆盖率虽提升至 78.6%,但仍有 6 个科室未覆盖;② 退回修改智能体中安全性维度占 50%,需加强准入评测中的安全审查;③ PACS 接口异常频次较高,资源对接稳定性有待提升。

下一步工作建议:① 制定未覆盖科室智能体引入计划,优先覆盖老年医学科与风湿免疫科;② 联合安全治理中心强化智能体安全审查;③ 推进 PACS 接口稳定性专项治理,目标月度故障 < 1 次。

— 报告结束 —

信息科管理员 · 2026-07-03 · 统一台账中心